

보험금사정서



비로결
손해사정

損害査定 바른결

바른결 손해사정

우 07805

서울시 강서구 공항대로 242, 열린M타워II차 1014호

TEL 02-6958-6866 FAX 02-6008-4695

담당자 : 김태윤 010-7400-4716
2026. 04. 09.

문서번호 : 제26-088호

수 신 : 농협손해보험

참 조 : 보험금 지급 담당자

제 목 : 손해 사정서 제출

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2025년 10월 16일 발생한 보험사고 당사자인 “ ”에 대한 손해사정을 완료하여 보험업감독규정 제9-18조 제1항의 규정에 의하여 보험금사정서를 작성하여 별첨과 같이 보험금사정서 등을 제출하오니 보험업감독규정 제9-21조 2항의 규정에 따라 지체없이 처리하여 주시기 바랍니다.
3. 본 사정서를 접수한 보험회사는 보험업감독규정 제9-21조의 제2항 제1호 또는 제2호에 해당되어 정정보완이 필요한 경우에는 동조 제3항의 규정에 따라 사정서 접수일로부터 반드시 10일 이내에 구체적인 사유와 근거를 명시하여, 당사의 책임 손해사정사 또는 보험금 청구권자에게 서면으로 요청하여 주시기 바랍니다.
4. 의뢰인에게 보험약관에 의거 보험회사와 보험금 지급 등에 관하여 분쟁이 있는 경우 관리 감독기관에 설치된 보험분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있음을 알렸습니다.

※ 별 첨 : 보험금사정서 1부

바른결손해사정



바른결
손해사정

바른결 손해사정
CLAIM ADJUSTMENT

서울특별시 강서구 공항대로 242, 1014호

1. 사정 요약

1. 사정 근거

- 가. 농협손해보험 (무) NHG헤아림365건강보험[1종:갱신형,납입면제형]2310 약관
나. 보험계약법

2. 사정 금액

가. 특별약관

뇌혈관질환진단비	금	20,000,000원
보험금 합계	금	20,000,000원

3. 보험금사정 의견

위 보험금 사정금액은 보험업법 제188조에 의하여 위 보험의 약관, 관련 법규, 해당 주치의가 발행한 진단서, 의무기록, 의료자문 결과 등을 근거로 본 손해사정사가 사정한 의견으로 피보험자 “윤광석”님의 보험금으로 타당하다고 판단됩니다.

2026. 04. 09.

책임사정사 김 태 윤



II. 위임 및 보험계약사항

1. 보험금사정업무의 위임

가. 수임내용

본건 보험사고로 인한 피보험자 “ ” 본인으로부터 농협손해보험의 보험금 사정에 대하여 보험업법 제188조의 규정에 따라 보험금사정업무를 의뢰 받음.

나. 피보험자의 인적사항

- 1) 성 명 :
- 2) 생년월일 :
- 3) 주 소 :
- 4) 연 락 처 :

다. 위임자

위 사고당사자임

라. 손해사정 업무를 수행하는 손해사정사

- 1) 신체손해사정사 : 김태운 (금융감독원 등록번호 BD00001058호)
- 2) 소속 : 바른결손해사정
- 3) 연락처 : 010 - 7400 - 4716

마. 상세 수임내용

1) 피해자 의 2025년 10월 16일 질병사고 인하여 발생한 갱신형 뇌혈관질환진단비(355간편가입) 특약의 손해사정

2. 보험계약사항

보험종목	증권번호	보험기간	계약자	피보험자	수익자
(무) NH헤아림355 건강보험 [1종:갱신형, 납입면제형] 2310		2023. 11. 22. ~ 2043. 11. 22.			

Ⅲ. 보험사고 발생의 조사·확인한 사실

1. 진단경위

피보험자는 두통 및 어지럼증으로 서울시 영등포구 소재
에 내원하여 2025. 10. 10. 시행한 뇌 MRI 검사상 양측 뇌실 주변
및 대뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견이 확인되었다 진단받음.

2. 치료관계내역

가. 주요 상병명

기타 명시된 뇌혈관질환 (I678)

다. 현 상태

피보험자는 현재까지 지속적인 치료를 받고 있으나, 뇌혈관질환으로 인하여 향후 지속적인 경과 관찰을 요하는 상태임.

IV. 관계법규 및 약관의 적용·판단

1. 보험금 지급책임 발생

가. 보험금의 지급사유

1) 갱신형 뇌혈관질환진단비(355간편가입)보장 특별약관

회사는 보험증권에 기재된 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 「뇌혈관질환」으로 진단 확정된 경우에는 최초 1회에 한하여 뇌혈관질환진단비로 보험수익자에게 지급합니다.

나. 특별 약관의 적정성 여부

1) 뇌혈관질환의 정의 및 진단확정

분류항목	분류번호
1. 거미막하출혈	I60
2. 뇌내출혈	I61
3. 기타 비외상성 두 개내출혈	I62
4. 뇌경색증	I63
5. 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중	I64
6. 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착	I65
7. 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착	I66
8. 기타 뇌혈관질환	I67
9. 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애	I68
10. 뇌혈관 질환의 후유증	I69

① 이 특별약관에서 「뇌혈관질환」이라 함은 제8차 한국표준질병·사인분류에 있어서 「뇌혈관질환」으로 분류되는 질병(【별표16】『뇌혈관질환 분류표』참조)을 말합니다.

② 「뇌혈관질환」의 진단확정은 의료법 제3조(의료기관)제2항에서 정한 국내의 병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사(치과의사 제외) 면허를 가진 자에 의하여 내려져야 하며, 이 진단은 병력, 신경학적 검진과 함께 뇌전산화단층촬영(brain CT scan), 자기공명영상(MRI), 뇌혈관조영술, 양전자방출단층술(PET), 단일광자방출 전산화 단층술(SPECT), 뇌척수액검사 등을 기초로 하여야 합니다. 그러나 피보험자가 사망하여 상기에 의한 진단이 가능하지 않을 때에는 피보험자가 「뇌혈관질환」으로 진단 또는 치료를 받고 있었음을 증명할 만한 문서화된 기록 또는

증거가 있어야 합니다.

피보험자의 진단명인 기타 명시된 뇌혈관질환(I678)은 뇌혈관질환 분류 표 8호 기타 뇌혈관질환 (I67)에 해당하고,

또한, 2026년 04월 03일 시행한 결과에 따르면
에 내원하여 뇌 MRI 검사 결과 양측 뇌실 주변 및 대
뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견이 확인 되었으며 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변)의 정도는 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 진단 부여에 있어 중요한 판단요소 중 하나이며 경도의 백질 변화라 하더라도 환자의 연령, 고혈압 등 기저 위험인자, 임상 증상과의 연관성을 종합적으로 고려하여 뇌소혈관질환의 초기 단계로 판단되는 경우에는 I67.8 진단을 적용할 수 있다라는 자문의 소견이 확인 됨. (백질변성의 정도는 I67.8 진단 여부를 결정하는 절대적인 기준은 아니며, 영상 소견의 정도와 함께 임상적 맥락을 종합적으로 평가하여 판단하는 것이 의학적으로 타당함)

다. 보험금 지급책임

[별첨 제01호] 진단서와 같이 피보험자는 임상증상인 두통 및 어지럼증으로 에 내원하여 뇌 MRI 검사 상 양측 뇌실 주변 및 대
뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견이 확인 되었으며 “기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8)” 최종진단 받은 사실이 확인되어 보험 약관에서 정한 갱신형 뇌혈관질환진단비(355간편가입)에 해당하는 보험회사의 보험금 지급책임이 발생함.

2. 면책사유 검토

가. 해당보험 보통약관 [보험금을 지급하지 않는 사유]에서는 피보험자, 수익자, 계약자의 고의로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 아니하거나 보험료의 납입을 면제하지 아니함과 동시에 이 계약을 해지할 수 있다고 명시하고 있으나,

나. 본 보험사고는 해당약관 [보험금을 지급하지 않는 사유]에 해당되는 사항이 없으므로 보험회사의 보험금지급책임은 당연히 존재한다 할 것임.

V. 보험금 사정

1. 보험금 사정내역

갱신형 뇌혈관질환진단비(355간편가입) : 20,000,000원

2. 보험금 사정금액

위의 제반 검토내용을 토대로 볼 때 상기의 금액을 피보험자의 보험금으로 사정하는 것이 적절하다 하겠음.

—금 이천만원整 (₩20,000,000)—

3. 사정 결과 및 의견

본 손해사정은 보험약관 및 진단서, 의무기록, 의료자문결과지 등을 근거로 사정한 것으로 피보험자의 보험금으로 적정하다고 판단됨.

한편, 본 사고가 원인이 되어 보험금 사정 시점에 예기치 못한 추가보험금이 발생할 경우에 대하여는 보험금 사정을 유보함.

Ⅵ. 증빙자료

1. 진단서
2. 초진기록지
3. 경과기록지
4. 영상판독지
5. 검사결과지
6. 의료자문결과지
7. 보험증권 사본
8. 신분증 및 통장사본
9. 위임장 사본

책임사정사 김 태 윤



문서확인번호

본 증명서는 발급일로부터 90일까지 <http://hangam.net/cert11.com>에서 원본확인이 가능합니다.

표 의료법 시행규칙 [별지 제5호의2서식] <개정 2019.8.27>

진 단 서

증표번호			
연 번 호			
환자의 성명	_____	환자의 주민등록번호	_____
환자의 주소	(전화번호 : _____)		
임상적 추정 질환진단 ☐ ☒	병 명 (후혈변·부상) 기타 명시된 뇌혈관질환		질병분류기호 1678
발병 연월일	환자진술	진단 연월일	
치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견	상기 환자는 두통, 어지럼증으로 내원하여 상병명으로 진단 받고 외래 통원치료 중입니다. 향후 일정 기간 이상의 경과 관찰 및 통원 치료가 필요할 것으로 예상됩니다. 마발견중이나 합병증 발생시 추가 진단이 필요할 수 있습니다.		
입원·퇴원 연월일	입원일: _____	부더	퇴원일: _____
용 도	보험사 제출용		
비 고			

「의료법」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제9조제1항에 따라 위와 같이 진단합니다.

의견기관 명칭 :

주소 :

2025년 10월 18일

☒ 의사 ☐ 치과 의사 ☐ 한의사 연재번호 제 _____ 호

성 명 :

등록번호:
성명:
주민번호:
진료일:

나이/성별:

외래기록지

● [2025-09-30 10:57]

주호소 증상

두통, 어지럼증

통증평가(있을 경우 하단 버튼 눌러 평가)

Numeric Rating Scale : 중등도[6]

◆ 중등도 이상의 통증에 대한 중재 :

- 관찰 (observation)

◆ 통증의 양상 : 쑤심

◆ 통증의 위치 : 머리 전체

◆ 통증의 빈도 : 간헐적

◆ 통증의 기간 : 1분

Present illness

2025-04부터 갑자기 시작된 두통, 어지럼증으로 진료위해 내원함.

#무직

Past history

HTN(-) / DM(-) / Tbc(-) / Hepatitis(-) / Cancer(-)/ 골다공증/심근경색/DL/전립선 비대증

[self po]

포렌드플러스디정 1T D (골대사관련약) -> 2025.04.11 마지막 복용

애드칼정 2T D (칼슘,비타민 D)

로스톤정5mg 1T D (고지혈증 치료제)

몰시톤정4mg 1T D (협심증 치료제) -> 두통 시 타이레놀 복용 or 감량함.
일성이습틴서방정18 0.5T D (칼슘채질 길항제)

탐루신디서방정 0.4mg 1T D (전립선 비대약)

Family History

HTN(-) / DM(-) / Tbc(-) / Hepatitis(-) / Cancer(-)/ 뇌출혈/ 뇌경색

- 부: 뇌출혈

- 모: 뇌경색

Social history

Alcohol(-) / Smoking(+) / Exercise(+)

- 흡연: 하루에 2갑

- 권투: 하루에 2시간

Objective Data

MRI & MRA

Assessment/Impression

R/O SVD

Plan

2025-09-30 기록변경 불가능하다 설명드릴. MRI & MRA

알려지 여부

없음

작성자 :

● [2025-09-30 11:03

] 외래기록지

기록내용

Subjective Data

Objective Data

■ ■ 신경학적 검사(neurologic examination) ■ ■

■ Mental status & High cognitive function

- ▶ Level of consciousness : alert
- ▶ Orientation :
 - * time : normal
 - * place : normal
 - * person : normal
- ▶ Language :
 - * comprehension : normal
 - * verbal : normal

■ Cranial

- ▶ Pupil light reflex : * Lt : normal * Rt : normal
- ▶ Pupil size : isocoria * Rt : 3 / * Lt : 3 / * EOM : full
- ▶ Facial motor : normal
- ▶ Facial sensory : normal
- ▶ Tongue deviation : No
- ▶ Gag reflex : normal

■ Motor: (Power & Tone)

- ▶ Right upper : Grade V
- ▶ Left upper : Grade V
- ▶ Right lower : Grade V
- ▶ Left lower : Grade V
- ▶ Muscle tone : (normal)

■ Sensory

- ▶ Right touch : normal
- ▶ Pinprick : normal

■ Reflex

- ▶ Deep tendon reflex :
 - * Biceps - Right : 2+ Left : 2+
 - * Triceps - Right : 2+ Left : 2+
 - * Knee - Right : 2+ Left : 2+
 - * Ankle - Right : 2+ Left : 2+
- ▶ Pathologic reflex :
 - * Babinski - Right : No
 - * Babinski - Left : No
 - * Ankle Clonus - Right : No
 - * Ankle Clonus - Left : No
 - * Hoffman - Right : No
 - * Hoffman - Left : No

■ Cerebellar/ Vestibular function test

- ▶ Dysmetria : normal
- ▶ Romberg test : normal

■ Gait

- ▶ Gait : normal
- ▶ Tandem gait : normal

■ NIHSS : Total []

- 1a[] 1b[] 1c[] 2[] 3[] 4[]
- 5a[] 5b[] 6a[] 6b[] 7[] 8[]
- 9[] 10[] 11[]

Assessment/Impression

Plan

작성자 :

● [2025-10-16 14:53]

기록내용

Subjective Data

2025-04부터 갑자기 시작된 두통, 어지럼증으로 진료위해 내원함.

#무직

Objective Data

■ FINDING : - Pulse sequence: sagittal T1WI, axial T1 & T2 WI, FLAIR, SWI, coronal T2WI
- MRA: Intracranial and neck TOF, MRA
- Contrast [-]

1. Brain & cranial vault

- Minimal chronic ischemic lesions in both cerebral white matter.
- 4mm pineal cyst.
- No definite mass, hemorrhage, hydrocephalus, atrophy

2. Vasculature (MRA)

- No evidence of occlusion, stenosis nor aneurysm in visible arteries

3. Others

- Maxillary sinusitis, left with fungal ball.

【판독의/확인】

【처방일/보고일】 20250930 / 20251014

Assessment/Impression

Small vessel disease

Plan

2025-10-16 medication x 30 진단서 작성 -

나실 증명서 작성

작성자 :

● [2025-10-30 10:46]

기록내용

Subjective Data

2025-04부터 갑자기 시작된 두통, 어지럼증으로 진료위해 내원함.

Objective Data

■ FINDING : - Pulse sequence: sagittal T1WI, axial T1 & T2 WI, FLAIR, SWI, coronal T2WI

- MRA: Intracranial and neck TOF MRA
- Contrast [-]

1. Brain & cranial vault

- Minimal chronic ischemic lesions in both cerebral white matter.
- 4mm pineal cyst.
- No definite mass, hemorrhage, hydrocephalus, atrophy

2. Vasculature (MRA)

- No evidence of occlusion, stenosis nor aneurysm in visible arteries

3. Others

- Maxillary sinusitis, left with fungal ball.

【판독의/확인】

【처방일/보고일】 20250930 / 20251014

Assessment/Impression

Small vessel disease

Plan

2025-10-16 medication x 30 진단서 작성 - 사실 증명서 작성

2025-10-30 medication x 60 CT 문의 - 경미해서 의미 없다고 설명드릴

작성자 :

이 하 여 백

등록번호
성명
주민번호

성별

검사결과보고서

두부(MRI)

검사명 MRI(Brain+3D Angio)(원외 영상전문의판독)
진료의사 진료과

검사 실시일시 20251010 11:17
보고일시 20251014 11:19
보고의사

판독일시 20251014 11:19
판독의사

■ FINDING : - Pulse sequence: sagittal T1WI, axial T1 & T2 WI, FLAIR, SWI, coronal T2WI
- MRA: Intracranial and neck TOF MRA
- Contrast [-]

1. Brain & cranial vault
 - Minimal chronic ischemic lesions in both cerebral white matter.
 - 4mm pineal cyst.
 - No definite mass, hemorrhage, hydrocephalus, atrophy
2. Vasculature (MRA)
 - No evidence of occlusion, stenosis nor aneurysm in visible arteries
3. Others
 - Maxillary sinusitis, left with fungal ball.

검사명
진료의사

진료과

검사 실시일시
보고일시
보고의사

판독일시
판독의사

2026년 04월 03일

(전문의 번호:)

환자명

생년월일

성별

[질문 1] 일반적으로 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 정의 및 진단기준은 무엇인가요?

☒ 1. 정의

뇌혈관질환(I67)은 뇌혈관의 비정상적인 상태로 인해 발생하는 다양한 비염증성 질환을 포함합니다. 이 코드 하의 질환들은 대개 만성적이며, 급성 뇌혈관 사고(뇌졸중)와는 구분됩니다. 즉, 주로 만성 뇌혈관 질환을 지칭하는 경우가 많습니다.

☒ 2. 진단기준

진단 기준은 질환의 유형에 따라 다르지만, 공통적으로 사용되는 평가 방법들은 다음과 같습니다:

임상 증상: 만성적이고 진행성인 뇌기능 저하, 두통, 어지럼증, 경련 등.

영상학적 검사: MRI, CT, 뇌혈관조영술(angiography) 등을 통해 혈관의 구조적 이상을 확인합니다.

혈관 기능 평가: 도플러 초음파를 통해 혈류의 이상 여부를 평가할 수 있습니다.

병리학적 검사: 필요한 경우, 뇌조직의 생검을 통해 혈관 벽의 변화를 확인할 수 있습니다.

☒ 3. 진단 범위

I67 뇌혈관질환 진단에는 파열되지 않은 뇌혈관의 박리증, 동맥류 및 동정맥류, 뇌혈관의 죽상경화증, 모야모야 병, 뇌혈관의 동맥염(arteritis), 뇌의 급성 또는 만성적인 허혈성 변화 (백질 변성, 소혈관질환 등) 또는 달리 분류되지 않는 뇌혈관 질환 (뇌출혈, 뇌경색, 뇌혈관협착증 이외)의 진단에 적용 됩니다.

[질문 2] . 진료기록부 및 영상자료 상, 환자의 내원경위, 신경학적 검진결과, Brain MRI+MRA 검사결과 주요 소견은 무엇인지요? (병변부위 영상자료 첨부 부탁드립니다)

☒ 상기 환자는 두통 및 어지럼증을 주소로 2025년 9월 30일 내원하였고 뇌MRI 검사 결과 양측 뇌실 주변 및 대뇌 피질하 백질의 소혈관질환 소견 확인되었습니다.

[질문 3] Brain MRI+MRA 검사결과 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변)은 어느 정도인가요? (Grade 0-3)

☒ 제출된 MRI 소견에서 확인되는 백질 고신호는 양측 뇌실 주변과 대뇌 백질의 경도의 변화로, 임상적으로 Fazekas grading 기준 Grade 1 수준의 백질변성에 해당합니다.

[질문 4] 상기 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변) 정도에 따라 기타명시된뇌혈관질환 I67.8 진단을 달리 하는지요? 판단의 이유는 무엇인지요?

☒ 양측 대뇌백질 변성(허혈성 병변)의 정도는 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 진단 부여에 있어 중요한 판단 요소 중 하나입니다. 경도의 백질 변화라 하더라도 환자의 연령, 고혈압 등 기저 위험인자, 임상 증상과의 연관성을 종합적으로 고려하여 뇌소혈관질환의 초기 단계로 판단되는 경우에는 I67.8 진단을 적용할 수 있습니다.

☒ 따라서 백질변성의 정도는 I67.8 진단 여부를 결정하는 절대적인 기준은 아니며, 영상 소견의 정도와 함께 임상적 맥락을 종합적으로 평가하여 판단하는 것이 의학적으로 타당합니다.

[질문 5] 신경학적 결손 또는 증상 유무에 따라 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8) 진단명 부여가 차이가 있는지요? 판단의 근거는 무엇인지요?

☑ 기타 명시된 뇌혈관질환(I67.8)의 진단은 반드시 신경학적 결손이 동반되어야만 부여되는 것은 아니며, 영상학적 이상 소견과 임상적 맥락을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

☑ 일반적으로 뇌혈관질환은 무증상 상태에서도 영상검사를 통해 발견되는 경우가 많으며, 특히 소혈관질환 (small vessel disease)이나 백질변성은 신경학적 결손 없이도 확인될 수 있습니다. 이러한 경우에도 해당 소견이 단순 노화 변화의 범위를 넘어 뇌혈관 병변으로 판단되고, 환자의 임상 증상(두통, 어지럼증 등) 또는 향후 뇌혈관질환 위험과의 관련성이 고려되는 경우에는 I67.8 진단을 부여할 수 있습니다.

☑ 따라서 신경학적 결손의 유무는 진단의 참고 요소 중 하나일 뿐 필수 조건은 아니며, 영상학적 소견의 존재 및 임상적 의미를 종합적으로 평가하여 판단하는 것이 의학적으로 타당합니다.

[질문 6] 제8차 한국표준질병사인분류(KCD)에 질병코딩지침에 따른 최종진단명 및 질병분류코드는 무엇인지요?

☑ I678 기타 명시된 뇌혈관질환 입니다.



보험증권

해아림

상 품 명: (무) NH해아림355건강보험[1종:갱신형, 납입면제형]2310

재발행

증권번호

계약일자

보험기간

계약기본사항

보험계약자

주인/사업자번호

(주)피보험자

주인/사업자번호

계약자주소

납입보험료

납입주기 월납

보장보험료

해일보험료

합인보험료

해당 없음

계약조건

100세만기/20년납/자동이체/고보장플랜2

만기환급금

예상환급금 (만기): 만기시 적립액

평가수익자

주인/사업자번호

지장대리인

주인/사업자번호

약관 및 기타

특약약관

* 특별약관 가입 및 담보내역은 증권보장부(별첨)에 의합니다.

유의사항

예금자보호안내

이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타 지급금을 합한 금액이 1인당 1억원까지(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 1억원까지 보호됩니다. 다만, 보험계약자 및 보험료납부자가 법인인 보험계약의 경우에는 보호되지 않습니다.

※ 이 보험증권은 계약체결의 증거로 발행되는 것이며, 실제 계약내용은 청약서 및 보험약관에 따릅니다.

NH농협손해보험

대표이사 송 춘 수





(무) NH해아림355건강보험[1종:갱신형,납입면제형]2310

계약자		증권번호	
피보험자	주변등록번호	직업	
나이/급수	운전형태		
주 소			
사망수익자	법정상속인	생존/입원수익자	

【보장내역】 기본계약

보장명	보장상세	가입금액 (만원)	납입 및 만기
기본계약(갱신형 일반상해사망보장(355간편가입))	상해사고로 사망한 경우 가입금액 지급	1,000	

【보장내역】 선택계약

보장명	보장상세	가입금액 (만원)	납입 및 만기
갱신형 보험료납입면제대상(355간편가입)	보험기간 중 보장개시일 이후에 암(유사암제외), 뇌졸중, 급성심근경색증, 상해 또는 진단확정된 질병으로 인한 80%이상 후유장애로 인한 지급사유가 발생한 경우 최초 1회에 한하여 가입금액 지급 ※ 암보장개시일은 최초계약의 경우 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 하며, 갱신계약의 경우는 이 계약의 갱신일로 합니다. 다만, 부활하는 경우 부활일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날을 암보장개시일로 합니다.	10	
갱신형 일반상해중환자실입원일당(1일이상180일한도)(355간편가입)	상해를 입고 그 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 최초 입원일로부터 입원1일당 가입금액 지급(1회 입원당 180일 한도)	30	
갱신형 뇌혈관질환진단비(355간편가입)	뇌혈관질환으로 진단 확정시 최초 1회에 한하여 가입금액 지급 (최초계약 가입 후 1년 미만시 가입금액의 50% 지급)	2,000	
갱신형 허혈성심장질환진단비(355간편가입)	허혈성심장질환으로 진단 확정되었을 때 최초 1회에 한하여 가입금액 지급 (최초계약 가입 후 1년 미만시 가입금액의 50% 지급)	2,000	
갱신형 뇌혈관질환수술비(355간편가입)	뇌혈관질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 수술 1회당 가입금액 지급 (최초계약 가입 후 1년 미만시 가입금액의 50% 지급)	500	
갱신형 허혈성심장질환수술비(355간편가입)	허혈성심장질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 수술 1회당 가입금액 지급 (최초계약 가입 후 1년 미만시 가입금액의 50% 지급)	500	

